

LSFMD El Kitabı

Disiplin Tüzüğü

İSTASYON GENEL BAKIMI

- Mutfak araç gereçleri hariç tüketilebilir/kullanılabilir her türlü ürün istasyon çalışanları tarafından alınır.
- Amerikan ve San Andreas Eyaleti harici hiçbir bayrak istasyona asılamaz.
- İstasyon temizliğinden personeller sorumludur. Ek bir çalışan bulunmaz.
- Üst katta bulunan yatakhane 24 saat mesaiye olan personeller dinlenmek amacıyla kullanabilir. Yatakhane boş ise personeller kalmak amacıyla da kullanabilirler.

İTFAİYE DEPARTMANI KILIK KIYAFET YÖNETMENLİĞİ

- Görev kıyafetleri düzgün, ütülenmiş ve temiz olmalı.
- Teçhizatlar eksiksiz ve bakımlı olmalı.
- Yüz bölgesinde dövme **bulunmamalı**.
- Erkekler için düzgün, düzenli bir saç ve sakal traşı olmalı (çene boyunu geçmeyecek sakallar kabul edilir).
- Kadınlar görev sırasında saçlarını toplamalı, açık bırakmamalı; aşırı makyajdan kaçınmalıdır.
- Saç rengi aşırı açık renk olmamalı (açık pembe, mavi, mor vb. tonları).
- Görev esnasında değerli takılar (altın bilezik, kolye vs.) olmamalı.
- Rozeti ve kurum logosunu kapatacak hiçbir ek aksesuar/kıyafet olmamalı.
- **Aktif standart saha görevinde izin verilen üniformalar aşağıdaki gibidir (bu üniformaların alt kısmını tüzüğe uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.):**

LSFD EMT Class B/C (Yakasındaki EMT yazısını kaldırmayı unutmayın. Kaldırmak için K menüsünden Tişörte tıklayın.)

LSFD T-Shirt

LSFD Winter Jacket

LSFD EMT Jacket

LSFD Usar Tech (üzerindeki kurtarma ekipmanları olmamalı)

- Alt kısım mevsime göre pantolon, tulum ya da diz boyunu geçmeyecek şekilde kapriden oluşabilir.
- LSFD Fireman Class A/B/C tören ve komuta takımı üniformalarıdır.
- Beyaz LSFD gömleğini İç İşleri Birim Personeli giyebilir.

• **Vakalara göre uygun kıyafetler aşağıdaki gibidir:**

- Yangın vakalarında tam teçhizat PPE Gear tulum gerekmektedir. Yangının büyüklüğüne göre bu üniformayı düzenleyiniz.
- Trafik kazası vakaları için LSFD Turnouts ya da LSFD Usar Tech giyilmelidir.
- Arama kurtarma faaliyetleri için uygun üniforma LSFD Usar Tech'dir.

• **OOO LSFD Birlik Kuralı aşağıdaki gibidir:**

- Mesai içerisinde AFK kalınmaz, karakter ceza alabilir.
- OOO sürekli huzursuzluk ortamı yaratmak ya da içerisinde olmak yasaktır,
- Gruplaşma, kayırma vb. döndürülmesi, FD chati harici yeni gruplar oluşturulması yasaktır.
- İzinsiz karakterini görev başında ya da dışında CK ile sonlandırmak yasaktır.
- \$400,000 üzerindeki değere sahip araçlara sahip olmak, kullanmak yasaktır.
- Ağır modifikasyonlu araçlara sahip olmak yasaktır. ((Paintjob, neon vs. Yarış kültürünü andıran araçlar.))

El Kitapçığı

1) TELSİZ KULLANIMI

Ön Bilgi

Telsiz anonsları anlaşılır ve düzgün bir dil kullanılarak verilmelidir. Anonslarda mutlaka ekip kodu ve lokasyon içermelidir.

KOD0 - KOD1 - KOD-5 ve durumları içeren telsiz kodları 25.02.2025 tarihinde güncellenerek tüzüğe dahil edilmiştir. Karmaşık kodlar yerine düz ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Dilerseniz aşağıdaki anlık kodları da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kodları kullanmak yerine söylemek hatalı bir kullanım şekli değildir. Personel tercihinə bırakılmıştır.

Durum Kodları:

KOD0: Acil çağrı, Kolluk Kuvveti talebi. (Memur vurulmuş olabilir, silah görmüş olabilir. /gdestek komutu kullanılmalıdır.)

KOD1: Baskı/Tehlike altında, Supervisor ve Kolluk Kuvveti talep ediyoruz. (Personelin kendini tehlike altında hissettiği, can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündüğü veya taciz'e uğradığı durumlarda kullanılır.)

KOD2: Sirenler, flaşörler ve tepe lambaları kapalı; çağrıya yöneliyoruz.

KOD2H: Flaşör ve tepe lambaları açık; çağrıya yöneliyoruz.

KOD3: Acil durum ışıkları ve sirenleri açık; çağrıya yöneliyoruz.

KOD4: Desteğe ihtiyaç yok, ayrılabilirsiniz.

KOD5: Vaka sonu, bölgeden ayrılıyor.

KOD6: Vaka incelemesi için araç dışına çıkıyoruz.

KOD7: İhtiyaç molası bildiriyoruz.

KOD9: Yöneldiğimiz ihbar asılsız.

Genel Kodlar:

10-04: Anlaşıldı/Olumlu.

10-05: Son anonsu tekrarlayın.

10-06: Son yapılan çağrıyı dikkate almayınız. (Anons iptal)

10-07: Çağrılara kapalıyız.

10-08: Çağrılara açığız.

10-12: Yetkili personel talep ediyoruz. (Supervisor)

10-18: Destek gerekiyor mu? ((/yt RA-1 to FR-3, 10-18 durumunuz nedir?))

10-20: Konum bildirimi - 10-21: Rapor verin / Durum bildirin.

Departman Telsizi Kullanımı (/d)

Departman telsizi diğer devlet kurumlarıyla (PD/SD/GOV) haberleşmek için kullanılır. Vaka esnasında polis ekibine ihtiyaç duyuyorsanız telsizden bunu bildirebilir ve polis ekibi talep edebilirsiniz. Sesleniş "LSFMD - LSPD, XXX konumuna YYYY nedeniyle polis ekibi talep ediliyor" şeklinde olmalıdır.

Operatör Telsizi Kullanımı (/operator)

Operatör, sahayı ve personelleri yöneten ve komutlar veren bir birimdir. Operatör guest bir karakter olduğundan oyundaki en yüksek rütbeli personel canlandırır.

Mesai Başlangıcı ve Bitişi

Mesai başlangıçlarında ve bitişlerinde mesaiye başlayan personel /t kanalından bunu bildirmelidir.

[1. Personel Rozet No] [Ana Kıdem] [Soyadı] mesai başlangıcı bildiriyor, Rockford Hills İstasyonu.

14478 İtfaiye Eri Walters, mesai başlangıcı bildiriyor, Rockford Hills İstasyonu.

[1. Personel Rozet No] [Ana Kıdem] [Soyadı] mesai sonu bildiriyor, Rockford Hills İstasyonu.

14478 İtfaiye Eri Walters, mesai sonu bildiriyor, Rockford Hills İstasyonu.

Devriye Başlangıcı ve Bitişi

Her devriyede /ekipkur ile ekip kurmak zorunludur. Devriye başlangıcı telsizinde anonsu veren kişinin personel numarası verilmesi gerekmektedir. Diğer ekip üyelerinin soyadı yer alması yeterlidir. Formata aşağıdan ulaşabilirsiniz:

[1. Personel Rozet No, Ana Kıdem, Soyadı] ve [2. Personel Ana Kıdem, Soyadı], XX ekip koduyla devriye başlangıcı bildiriyor.

Örnek;

14479 İtfaiye Eri Walters ve İtfaiye Eri Alberto, RA2 ekip koduyla devriye başlangıcı bildiriyor.

Devriye bitişi anonslarında ekip kodu ve “devriye bitişi” ibaresi yeterlidir (RA2, devriye bitişi).

Saha Ekibi Anonsları

- Bir çağrıya yönelirken bunu mutlaka belirtmelisiniz. Anonsunuz anlaşılır ve net olmalıdır. Ekip kurulduktan sonra daha fazla ekip üyelerinin anonsu geçilmez; yalnızca ekip kodu belirtilerek anons geçilir:

[Ekip Kodu] son departman telsizi çağrısına KOD3, Little Italy.

[Ekip Kodu] son departman telsizi çağrısına sirenler açık yöneliyoruz, Little Italy.

- Bir vakanın sonlanması akabinde vakanın akıbeti hakkında anons geçilir. Yaralı hastaneye mi sevk ediliyor, ayakta mı tedavi edildi yoksa ihbar asılsız mı değerlendirildi konuları hakkında bilgi içermelidir. Yaralı hastaneye sevk ediliyorsa yara hakkında detay da verilmelidir. Telsiz anonslarını MD personelleri de gördüğünden duruma göre acil ünitesini hazırlayacaklardır

[Ekip Kodu] vaka sonlandı, ateşli silahla karın bölgesinden yaralanan erkek vatandaş hastaneye sevk ediliyor, Idlewood.

[Ekip Kodu] ihbar asılsız değerlendirildi, KOD4, Idlewood.

- Bir vaka bölgesine ek destek ya da ünite gerekiyorsa telsizden anons geçilmelidir. Anonsta hangi ekibin gelmesi gerektiği de belirtilmelidir.

[Ekip Kodu] trafik kazası bölgesindeyiz, sürücü araçta sıkışmış. Buraya SQUAD ekibi gerekiyor, Rockford Hills.

[Ekip Kodu] ağaç yangınıyla karşılaştık, buraya ENGINE ekibi gerekiyor, Idlewood.

Yakın Telsiz Kullanımı

Yakın telsizler, yakın çevredeki ekiplerle iletişim kurmak içindir. Ana telsizlere göre günlük bir dil kullanılır. Vaka alanına giren ekibin desteğe ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için yakın telsiz üzerinden soru sorması tavsiye edilir. Örnek diyaloglara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

E1: FR8 burada, desteğe ihtiyacınız var mı?

E2: Gerek yok, teşekkürler. / Araç hasarlı, elektrik aksamını hallederseniz süper olur.

E1: İyi devriyeler. / Tamam, ilgileniyoruz.

E1: Walters, bana sedye getirir misin? Müdahale tamam.

E2: Getiriyorum!

2) PARAMEDİK BÖLÜMÜ

İlk Yardımın Temel Uygulamaları

- Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
- Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
- Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
- Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
- Sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.
- Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
- Kivılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.
- Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
- Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir

İlk Müdahalede Yapılması Gerekenler

- Hasta/yaralının durumu değerlendirilmeli,
- Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilmeli,
- Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilmeli,
- Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahale gerçekleştirilmeli,
- Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale edilmeli,
- Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmemeli,
- Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunulmalı,
- Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalı,
- Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.

Hasta ve Yaralı Değerlendirme

Solunum Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi(Airway)

- Hasta/yaralının ağız içini kontrol ederek yabancı cisim varsa işaret parmağınız ile çıkarın.
- Bir elinizi hasta/yaralının alına, diğer elin 2 parmağını çene kemiğinin üzerine koyun, alından bastırılarak başı geriye doğru itip baş-geri çene-yukarı pozisyonunu uygulayın

Solunumun Değerlendirilmesi(Breathing)

- Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 10 sn. süreyle değerlendirilir.

Dolaşımın Değerlendirilmesi(Circulation)

- Bilinci kapalı ve solunumu varsa; hasta/yaralının nabızı değerlendirilir,
- Yetişkin ve çocuklarda şah damarından 3 parmak ile 5 saniye,
- Bebeklerde kol atardamarından 3 parmak ile 5 saniye kontrol edilir.
- İlk değerlendirme sonucunda hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabızı varsa derhal koma pozisyonu verilerek diğer yaralılar değerlendirilir.

C.R.B.P. Değerlendirmesi

Bilinç Durumunun Değerlendirmesi(consciousness)

Öncelikle, hasta/yaralının bilinç durumu değerlendirilir.

Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir. Bilinç düzeyleri;

Kişinin bilinci yerinde ise = Tüm uyarılara cevap verir.

Birinci Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyarılara cevap verir.

İkinci Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyarılara cevap verir.

Üçüncü Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyarılara karşı tepkisizdir, cevap vermez,

Kodlama;

A: Alert – Uyanık, bilinci açık (yere, kişiye, zamana oryantasyonu da kontrol edilir)

V: Verbal – Hasta sözel uyarıya(komutlara) yanıt veriyor

P: Painful – Hasta ağrılı uyarana yanıt veriyor

U: Unresponsive – Hastanın bilinci kapalı, hiçbir şekilde yanıt vermiyor.

Solunum Değerlendirilmesi(respiration)

Hasta/yaralının solunumu değerlendirilirken;

Solunum sıklığına, solunum aralıklarının eşitliğine, solunum derinliğine bakılır.

Kişinin 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır.

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20,

Çocuklarda 16–22,

Bebeklerde 18-24'dür.

Kan Basıncının Değerlendirilmesi(blood pressure)

•Hasta/yaralı değerlendirilirken kan basıncı kontrol edilmez. Ancak, kan basıncının anlamının bilinmesi önemlidir.

•Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri 50/100- 100/140 mm Hg'dir

Nabız Değerlendirilmesi(pulse)

Nabız Değerlendirilmesi:

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denmektedir.

Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100,

Çocuklarda 100–120,

Bebeklerde 100-140'dır.

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Şah damarı (adem elmasının her iki yanında)

Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)

Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde)

Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)

Hasta/yaralıların dolaşımını değerlendirirken, çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atardamarından nabız alınır.

Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım

•Triaaj alanı belirleyin. Hasta/yaralının bilincini kontrol edin.

•Hasta/yaralının yaşam bulgularını değerlendirin.

•Yaranın üzerini tercihen sarılmış bez ile kapatın.

•Kanamayı durdurun, infüzyon tedavisine başlayın.

•Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucunu açık bırakın.

•Bilinç açık ise hasta/yaralıyı yarı oturur pozisyonda tutun.

•Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey vermeyin. Hasta/yaralının yaşam bulgularını sık sık kontrol edin. Şok önlemlerini alın. Transfer edin.

Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım

- Trijaj sırasını belirleyin.
- Hasta/yaralının bilinç kontrolünü yapın.
- Hasta/yaralının yaşam bulgularını kontrol edin.
- Dışarı çıkan organları içeri sokmaya çalışmayın, üzerlerini geniş, nemli ve temiz bir bezle örtün.
- Kanamayı durdurun, infüzyon tedavisine başlayın.
- Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırın, ısı kaybını önlemek için hasta/yaralının üzerini örtün.
- Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey vermeyin.
- Yaşam bulgularını sık sık izleyin.
- Transfer edin.

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım

- Trijaj sırasını belirleyin.
- Bilinç ve diğer yaşam bulgularını değerlendirin.
- Bilinci açıksa; hasta/yaralının hareket etmemesini sağlayın.
- Herhangi bir tehlike söz konusu ise ayaklarından tutarak düz pozisyonda sürükleyin.
- Kanamayı durdurun, infüzyon tedavisine başlayın.
- Hasta/yaralının olay yerinde, taşıma ve sevki sırasında; baş-boyun-gövde ekseninin bozulmamasına ve sarsıntıya maruz kalmamasına dikkat edin.
- Tüm yapılanları ve hasta yaralı hakkındaki bilgileri kaydedip rapor tutun.
- Hasta/yaralıyı asla yalnız bırakmayın.
- Transfer edin.

Ateşli Silahla Yaralanma İlk Yaklaşım

Birincil Değerlendirme Sonucu olabilecek Travmalar

- Hayati tehlike oluşturan Multiple Travma
- Hipoksi
- Taşikardi
- Hipotansiyon
- Solunum yolu açıklığının, solunum değerlerinin ve kan dolaşımının değerlendirilmeleri yapılmalıdır. (Airway, Breathing, Circulation)
- İntravenöz yolu açılıp sıvı infüzyonu sağlanmalıdır. (IV)
- Kurşun giriş ve çıkışları izlenmeli, hasta fazla kan kaybetmeden yaranın tanısı yapılmalıdır.
- Kurşun içerideyse herhangi bir müdahale yapmamalı, ana amacınızı hasta/yaralının durumlarını stabilde tutmak ve daha fazla kan kaybetmesini engellemeye adanmıştır.
- Kan kaybetme durumuna bağlı olarak kullanabileceğiniz ve olay yerinde sizi kurtaracak en önemli malzeme gazlı bez/spanç olabilmektedir.
- Her 5 dakikada bir hasta/yaralının vital bulguları kontrol edilmeli, uygun Ambulans olay yerindeyse transferi gerçekleştirilmelidir. Hasta/yaralı daha fazla olay yerinde bekletilemez. (olay yerinde yapılacak müdahaleler sınırlıdır, bu kuralı göz önünde bulunduralım)

Örnek Müdahale

- Yaralının nabzını kontrol edin,
- Yaralıya bilinç kaybı yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için sorular sorun (Beni duyuyor musun, ismin ne? vb.)
- Oksijenli suyla yara bölgesini temizleyin,
- Gazlı bez paketini açarak yaraya uygulayın,
- Travma bandajı rulosuyla yarayı sarın, bandajı uygun boyutta kesin,
- Bandajı flaster ile sabitleyin,
- Yaralıyı ana sedyeye alın, sedye kemerlerini bağlayın.

Tıkanmalarda İlk Yardım

Solunum yolunun, solunumu gerçekleřtirmesi iingerekli havanın gemesine engel olacak řekilde tıkanmasıdır.

Kısmi Tıkanma

Az da olsa, bir miktar hava geişinin olduėu duruma kısmi tıkanma denir. Kiři ksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak kiřiye dokunulmaz ve ksürmeye teşvik edilir.

Tam Tıkanma

Hava girişinin tamamen engellendiėi duruma ise tam tıkanma denir. Kiři nefes alamaz, acı eker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarır.

Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada İlk Yardım

- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
- Hastanın bilinci kontrol edilir.
- Hastanın sırtına iki kürek kemiėi arasına 5-7 kez vurulur.
- Ağız ierisinde bulunan cismin ıkıp ıkmadıėı kontrol edilir.
- ıkmadıysa, arkadan sarılarak hastanın gövdesi kavranır.
- Bir el yumruk yapılarak, başparmak ıkıntısı midenin üst kısmına, göėüs kemiėi altına gelecek řekilde konur. Diėer el ile yumruk yapılan el kavranır.
- Kuvvetle arkaya ve yukarı doėru bastırılır. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim ıkıncaya kadar tekrarlanır.

Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

Bayılma (Senkop), beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır.

Bayılma nedenleri:

- Sıcak ve yorgunluk,
- Korku ve aşırı heyecan,
- Aniden ayağa kalkma,
- Kan şekerinin düşmesi,
- Şiddetli enfeksiyonlar.

Bayılma belirtileri:

- Baş dönmesi, baygınlık ve yere düşme,
- Bacaklarda uyuşma, bilinçte bulanıklık,
- Yüzde solgunluk,
- Üşüme ve terleme,
- Hızlı ve zayıf nabız.

Kişi başının döneceğini hissederse:

- Sırt üstü yatırın; ayaklarını 30 cm. kaldırın (Şok Pozisyonu),
- Sıkan giysilerini gevşetin,
- Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesini sağlayın.

Kişi bayıldı ise;

- Etraftaki meraklıları çevreden uzaklaştırın,
- Hasta/yaralıyı sırt üstü yatırın ve ayaklarını 30 cm yukarı kaldırın.
- Solunum yolu açıklığını kontrol edin ve koruyun.
- Sıkan giysileri gevşetin.
- Kusma varsa yan pozisyonunda tutun

Koma Pozisyonu ve Koma Hakkında

Koma Nedir?

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dıştan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.

Koma nedenleri;

- Düşme ya da şiddetli darbe, kafa travmaları,
- Zehirlenmeler,
- Şeker hastalığı,
- Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı
- Havale vb. ateşli hastalıklar,
- Karaciğer hastalıkları

Koma belirtileri;

- Yutkunma, öksürük vb. tepkilerin kaybolması,
- Sesli ve ağırlı uyarılara cevap vermeme hali,
- İdrar ve dışkı kontrolünün kaybolması

Komada İlk Yardım

- Olay yerinin güvenliğini sağlayın.
- Hasta/yaralının yaşam bulgularını değerlendirin.
- Hasta/yaralının bilincini kontrol edin.
- Solunum yolu açıklığını sağlayın.
- Koma pozisyonu verin ve biraz bekleyin.
- Hasta/yaralıyı kendine gelene kadar ve diğer işlemler bitene kadar yalnız bırakmadan değerlendirmeleri hep yapın.
- Koma Pozisyonu Nasıl Yapılır?
- Hasta/yaralıyı sesli veya omzundan hafif sarsın; uyarı vererek bilincini kontrol edin.

Sıkran giysilerini gevşetin.

- Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.

- Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunumunu kontrol edin.
- Şah damarından(karotis arter) nabzını kontrol edin.
- Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökün.
- Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolunu karşı omzunun üzerine koyun.
- Karşı taraftaki bacağını dik açı yapacak şekilde kıvrın.
- İlk yardımcıya yakın kolu, baş hizasında omuzdan yukarı uzatın.
- Karşı tarafı omuz ve kalçadan tutarak bir hamlede çevirin.
- Üstteki bacağı, kalça ve dizden bükerek öne doğru destek yapın.
- Altta bacak hafif dizden bükerek arkaya destek yapın.
- Başı, uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konuma getirin.
- 3–5 dakika ara ile solunum ve nabızı kontrol edin

Şok Pozisyonu ve Şok Hakkında

Şok Nedir?

Dolaşım sisteminin yaşamsal organlara yeterince kan gönderememesi nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliği durumudur.

Şok Çeşitleri Nelerdir?

- Kardiyojenik şok (kalp kökenli)
- Hipovolemik şok (vücutta sıvı eksikliği/kaybı)
- Toksik şok (zehirlenmeye bağlı)
- Anaflaktik şok (alerjiye bağlı)

Şok Belirtileri Nelerdir?

- Kan basıncında düşme,
- Hızlı ve zayıf nabız,
- Hızlı ve yüzeysel solunum,
- Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik, endişe ve huzursuzluk.
- Baş dönmesi, dudak çevresinde solukluk ya da morarma, susuzluk hissi,
- Bilinç seviyesinde azalma.

Şokda İlk Yardım

- Mümkün olduğunca temiz hava solumasını sağlayın.
- Hasta/yaralının endişe ve korkularını giderin.
- Hava yolunun açıklığını sağlayın.
- Kanama varsa hemen durdurun.
- Şok pozisyonu verin.
- Hasta/yaralıyı sıcak tutun.
- Hasta/yaralıyı gereksiz yere hareket ettirmeyin.
- Hasta/yaralının 3-5 dakikada bir genel değerlendirmesini yapın.

Şok Pozisyonu Nasıl Yapılır?

- Hasta/yaralıyı düz olarak sırt üstü yatırın.
- Hasta/yaralının bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak, bacakların altına destek koyun (Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.).
- Hasta/yaralının üzerini örterek ısınmasını sağlayın.
- Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalın.
- Belli aralıklarla (2–3 dakikada bir) yaşam bulgularını değerlendirin.

Kanamalarda İlk Yardım

Kanama Nedir?

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücut içine ya da dışına) çıkmasına kanama denir.

Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar

Dış Kanamalar: Kanın vücut dışına doğru akmasıdır.

İç Kanamalar: Kanın vücut içine akmasıdır.

Doğal Deliklerde Meydana Gelen Kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs (makat) ve üreme organlarından olan kanamalardır.

Dış Kanamalarda İlk Yardım

- Yara üzerine direkt baskı uygulayın.
- Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırın.
- Gerekirse bandaj ile sarıp kanlanmış bezleri kaldırmadan basıncı arttırın.
- Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına basınç uygulayın.
- Kanayan bölgeyi yukarı kaldırın.
- Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa kanama bölgesini kalp hizasından yukarıda tutun.
- Şok pozisyonu verin.
- Sık sık yaşam bulgularını kontrol edin. (2-3 dk. arayla)

Turnike Uygulama Koşulları

- Uzuv kopmuşsa,
- Tüm kanama durdurma uygulamaları yetersiz kalıyorsa,
- Hasta/yaralının uzun mesafede taşınması gerekiyorsa,
- Çok sayıda hasta/yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa uygulanır.

İç Kanamalarda İlk Yardım

- Hasta/yaralının bilincini ve solunumunu değerlendirin.
- Üzerini örterek ayaklarını 30 cm. kaldırın.
- Asla ağızdan yiyecek içecek vermeyin.
- Kapalı kırık varsa, kan damarlarının yaralanmasını önlemek ve bir iç kanamaya sebep olmamak için hasta ya da yaralının hareketsiz kalmasını sağlayın.
- Hasta/yaralının şok pozisyonunda yaşamsal değişimlerini izleyin.

Burun Kanamasında İlk Yardım

- Hastanın başını öne doğru eğin. Mümkünse oturtun.
- Burun kanatlarını sıkıştırarak iki parmağınızla sıkın.
- Bu işleme yaklaşık 5 dakika kadar devam edin.
- Kanamanın durmaması halinde hasta ya da yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna götürün.

Kulak Kanamasında İlk Yardım

- Kanama hafifse kulağı temiz bir bezle temizleyin.
- Ciddi ise kulağı tıkamadan gazlı bezle kapatın.
- Hasta/yaralının hareketsiz olarak, kanayan kulak üzerine yan yatmasını sağlayın.

Yanıklarda İlk Yardım

Yanık Nedir?

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır.

Yanık Çeşitleri

1'inci Derece Yanıklar:

- Alt deride ve derinin yüzeyinde, kızarıklık, (pembe, kırmızı arası renk) şeklinde görülen doku hasarı vardır.
- Ağrı vericidir.
- Yanık bölgede ödem ve hafif şişlik vardır.
- Genelde 48 saatlik süreç içinde iyileşir.

2'inci Derece Yanıklar:

- Derinin 1. ve 2. tabakasını etkiler.
- En bariz özelliği deride içi su dolu kabarcıklar (bül) oluşmasıdır.
- Derinin kendini yenilemesiyle kendiliğinden iyileşir.
- Çok ağrılıdır.

3'üncü Derece Yanıklar:

- Derinin tüm tabakaları etkilenir.
- Kaslar, sinirler, damarlar üzerinde etkilidir.
- Beyaz kuru yaradan, siyah renge kadar aşamaları vardır.
- Ağrısızdır, çünkü bütün sinirler zarar görmüştür.

Yanıklarda İlk Yardım

- Kiři hala yanıyorsa panik yapmayın; hareket ediyorsa kořmasını engelleyin.
- Hasta/yaralının zerini battaniye vb. ile kapatın ve yuvarlanmasını saęlayın.
- Yařam bulgularını deęerlendirin.
- dem oluřabileceęinden yzk, bilezik vb. aksesuarlarını ve giysilerini ıkarın.
- Deriyi sabunlu su ile dikkatle temizleyin.
- Su toplayan yerleri patlatmayın.
- Yanık blgelere bandaj uygulamayın.
- Yanıęın zerini temiz bezle rtn; zerine hibir madde srmeyin.
- Hasta/yaralıyı battaniye ile rtn.
- Alüminyum Yanık rtsn kullanın.

Kırık, ıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık Nedir?

Kemik btnlęnn bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendilięinden oluřur.

Kırık eřitleri

Kapalı Kırık: Kemik btnlę bozulmuřtur. Ancak deri saęlamdır.

Aık Kırık: Deri btnlę bozulmuřtur. Kemik uları dıřarı ıkabilir, beraberinde kanama ve enfeksiyon riski vardır.

Paralı Kırık: Kemik birden fazla yerden kırılmıřtır.

Kırık Belirtileri Nelerdir?

- Blgenin hareket edilmesi ile artan yoęun aęrı,
- řekil bozukluęu (Dięer saęlam organ ile karřılařtırılır),
- Blgede dem ve kanama sonucu morarma,
- İřlev kaybı,
- Hareketlerde kısıtlama,
- řiřlik.

Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar:

- Kırık yakınındaki damar, sinir ya da kaslarda yaralanma ve sıkışma (Kırık bölgede nabız alınamaması, soğukluk, solukluk, aşırı hassasiyet),
- Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok,
- Açık kırıklarda enfeksiyon riski görülebilir

Kırıklarda İlk Yardım

- Yaşamı tehdit eden başka yaralanma varsa önceliği ona verin.
- Hasta/yaralıyı hareket ettirmeyin.
- Ani hareketlerden kaçının, kırığı yerine koymaya çalışmayın.
- Kırık kolda ise; ödem oluşacağından yüzük, saat vb. eşyaları çıkarın.
- Kırık olan bölgenin hareket etmesini önleyin.
- Açık kırık varsa; tespitten önce yaranın üzerini temiz bir bezle kapatın.
- Kırık olan bölgeyi bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edin.
- Tespit edilen bölgeyi yukarıda tutarak dinlenmeye alın.
- Kırık bölgedeki nabızı ve derinin rengini kontrol edin.
- Hastayı sıcak tutun.
- Kırık olan bölgenin hareket ettirilmesine izin vermeyin.
- Atel gibi şeyleri kullanın,
- Atelden sonra Üçgen Bandaj desteğini sağlayabilirsiniz.
- Hastanın sakin olmasını söyleyin ve yarasına bakmasını.

Burkulma Nedir?

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

Burkulmalarda İlk Yardım

- Burkulan eklemi sıkıştırıcı bir bandajla dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edin.
- Şişliği azaltmak için bölgeyi yukarı kaldırın.
- Soğuk uygulama yapın. (buz aküsü ile birlikte tedavi)
- Bölgeyi hareket ettirmeyin.

Çıkık Nedir?

Çıkık; eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

Çıkıkta İlk Yardım

- Eklemi bulunduğu şekilde tespit edin.
- Çıkığı asla yerine oturtmaya çalışmayın.
- Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey vermeyin.
- Bölgedeki nabız, deri rengi ve ısıyı kontrol edin.
- Tıbbi yardım sağlayın.

Temel Yaşam Desteği

Solunum ve Kalp Durması Nedir

Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

Kalp durması: Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyarılara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.

Temel Yaşam Desteği Nedir?

Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

Yetiřkinlerde Dış Kalp Masajı ve Yapay Solunum

- 1- Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,
- 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise:
- 3- Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır,
- 4- Hasta/yaralının yanına diz çökülür,
- 5- Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,
- 6- Hasta/yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır,
- 7- Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğel elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,
- 8- Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,
- 9- Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir: Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
- 11-Eğilip, kulağını hastanın ağızına yaklařtırarak solunum dinlenirken diğel el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.
- 12- Hasta/ yaralının solunumu yok ise,
- 13- Hasta/ yaralıya kalp basısı uygulamak için göğüsün merkezine bir elin topuğı yerleştirilir (göğüs kemiğinin alt yarısına),
- 14- Diğel el bu elin üzerine yerleştirilir,
- 15- Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,
- 16- Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiğı üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur,
- 17- Göğüs kemiğı 5 cm ařağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,
- 18- Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,
- 19- Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatılır,
- 20- Normal bir soluk alınır**, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağızını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,
- 21- Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,
- 22- Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2) Temel yaşam desteğıne hasta/yaralının yaşamsal refleksleri geri gelene kadar devam edilir.

Suni Teneffüs

- İlk olarak kişi yan yatırılarak ağızdaki yabancı cisimler çıkartılır.
- Sonra kazazede tekrar sırt üstü yatırılır.
- İşaret parmağımızla ağızdaki kalan yabancı cisimler çıkartılır.
- Kazazedenin sağ tarafına diz üstü çökülür.
- Sağ elimizle kişinin boynundan yukarı doğru kaldırarak nefes yolu açılır ve elimiz burada tutulur.
- Sol elimizle de burun delikleri tıkanarak vereceğimiz nefesin geri çıkması engellenir.
- Kazazedenin ağzına, dudağımızı tam temas ettirerek normalde verilen nefesin biraz daha fazlası üflenir. Çok fazla değil normalin birazcık daha fazlası yeterli. (Suni solunum maskesini kullanabilirsiniz)
- Kişinin göğüs kafesi nefes verdiğimizde şişecektir. Bu işlemi nefes alıp verinceye kadar tekrar etmeliyiz. Yetişkinlerde bu işlem 15 kez tekrarlanmalıdır.

3) YANGIN BÖLÜMÜ

A TİPİ HORTUM

A tipi hortumlar alıcı hortumlardır. Büyük yangınlarda ENGINE'nin deposunun yetmediği durumlarda su hidrantlarından, gölden ya da en yakın sulak alandan **motopomp** yardımıyla su çekmeye yarar. A tipi hortumu B, C ya da D tipi hortuma bağlayarak yangına müdahalede bulunulur.

B TİPİ HORTUM

Uzak bir yere müdahale edildiğinde, aktarma hortumlarıdır. Su kaynağı ve yangına müdahale edilen bölge birbirinden oldukça uzaksa, diğer hortumlar bu hortumla klipslenir.

C TİPİ HORTUM

Araç, ağaç, çalılık, konteynır gibi küçük çaplı yangınlar için kullanılır.

D TİPİ HORTUM

Ev, işyeri ya da büyük çaplı yangınlarda kullanılan hortumdur. Yüksek basınç verir.

HORTUMU TAKMA İŞLEMİ

- Hortum ENGINE aracından alınıp, düz bir şekilde boş ve kısmen engebesiz bir zemine serilir.
- Ardından hortum, ENGINE aracındaki vericiye takılır.
- Vericiye takılan hortum tutulur, yangına müdahale edecek er tarafından taşınır.
- Personel fazlalığı varsa yangına müdahale edecek ere bir itfaiye eri daha destek olur, onun arkasından hortumu sürekli düzleştirir. Su akışının aksamasını engeller.

HORTUMU TOPLAMA İŞLEMİ

- Müdahale sonrasında hortum yine düz bir zemine serilir.
- Bir personel hortumun bir ucuna, diğer personel ise diğer ucuna geçerek karşılıklı durulur.
- Herhangi bir personel hortumu yuvarlayarak diğer ucu tutan personele yaklaşır.
- Hortum yuvarlanarak sarıldıktan sonra ikinci personel tarafından taşınır, araca yüklenir

MONİTÖRLE YANGINA MÜDAHALE ETME ve SOĞUTMA ENGINE MONİTÖRÜ

Yangına müdahalede bazen hortum yerine monitör de kullanılır. Genellikle çalı, ağaçlık alan yangınlarında monitörle müdahalede bulunulur. Monitör, ENGINE aracının üzerinde bulunan ve suyun çıkışını sağlayan aparatır. Bir personel monitörün başında durarak yönlendirir (rolünü yapar, diğer personel ise GTA motorları gereği araç içerisinden suyu yönlendirir).

TRUCK MONİTÖRÜ

Yerden yüksek alanlarda (çatı, üst kat yangınları vb.) hortum TRUCK aracının merdiven kısmındaki monitöre bağlanır. Bağlantı yapılan hortum B tipi hortumdur. Merdiven kurulduktan sonra merdivende olan personel monitörle yangına müdahalede bulunur.

SOĞUTMA İŞLEMİ

Soğutma işlemi yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılır. Bir daha yangının çıkmasını engellemek ve yakın çevreye sıçramasını önlemek için bu işlem gerçekleştirilir. Soğutma işlemi yine ENGINE'nin monitörüyle yapılır.

4) KURTARMA VE MÜDAHALE BÖLÜMÜ

* **TRUCK:** *İtfaiye kamyonetlerinin tümü (ladder, engine, squad vs.)*

Trafik Kazası ve Sıkışma Araçlı trafik kazası vakalarına **RA** ekibinin yanında **FR** ya da kazanın büyüklüğüne göre ENGINE/SQUAD ekibi de yönlendirilmelidir. RA ekibi medikal müdahaleyi yaparken, FR ya da ENGINE/SQUAD ekibi de sıkışma; elektrik kaçağı gibi durumlara müdahalede bulunur. Sıkışma durumu yoksa, araçtaki akü kesinlikle pasif hale getirilmeli ve yangın riski ortadan kaldırılmalıdır. Sıkışma durumu varsa aşağıdaki ekipmanlar yardımıyla durum ortadan kaldırılır:

Ayırıcı ve Kesici: Ayırıcı, büyük bir makasa benzeyen elektronik/şarjlı aletlerdir. Sıkışma durumu yaşanan demire müdahale edilir. Ayırmak gerekiyorsa ayırıcı ile demir gevşetilir ve müdahale için alan tanılır; kesmek gerekiyorsa sıkışıklık yaşanan bölge bu aletle kesilir.

Projektör / Işık Kulesi: Ayaklı bir ışık aletidir. FR ve TRUCK araçlarının kurtarma dolaplarında bulunduğu var sayılır. Karanlık bir ortamsa bu ışık aleti kurulur, ardından müdahaleye başlanır.

Sac Makası: Sac makas, yine demirleri ve sac aksanlarını kesmek için kullanılır. Kaputun bağlantı noktaları, kapıların bağlantı noktalarını birbirinden yırmak için bu alet tercih edilir.

İntihar Vakası

İntihar vakalarına LADDER, SQUAD ya da ENGINE araçlarından birisi yönelir. Mağdur kişi yüksekten atlamak isteyebilir. İntihar ikna görüşmesini polis ya da itfaiye ekibinden eğitim almış personeller yapar. Yönelen TRUCK ekiplerinden birisi muhtemel düşme noktalarına uygun şekilde atlama yatağını kurar. Atlama yatağı hava motoruyla şişirilir. Kurulum yapıldıktan sonra atlama yatağının üzerinde hiçbir madde ya da canlı olmamalıdır. Yine vaka sonunda atlama yatağı hava motoruyla indirilir ve kurtarma dolabına bırakılır. Bu süreçte RA ekibi durum ne olursa olsun mağdur vatandaşı olarak hastaneye bırakmak durumundadır. Tercihen iki RA yönelebilir (birisi muhtemel düşme noktasında, diğeri ise yüksek alanda hazır bekleyecek şekilde).

Kurtarma ve Merdiven Kurulumu

Yüksek bir alanda kalan hayvan ya da insanı kurtarmak için LADDER ekibi gerekir. LADDER aracının ayaklıkları düz bir zemine sabitlenir, ardından merdiven kurulumu yapılır. Kuleli merdivense merdiven uzatılırken personel kule içerisinde bekler. Kulesiz merdiven ise merdiven kurulumu sonrasında personel merdivene tırmanarak mağdura müdahalede bulunur. Kurtarılan mağdur RA ekiplerine sevk edilir.

5) İTFAİYE EKİPMANLARI

Uzaktan Kumandalı Monitör

Seyyar olarak itfaiye aracında bulunur. Yangına uzaktan müdahale yapmak için araçtan alınır ve hortum bu monitöre bağlanır. Monitör, uygun bir yere sabitlenir. Yangına uzaktan kumanda yardımıyla monitör kullanılarak müdahale edilir.



Sürgülü Merdiven

FR ve BATTALION ekibinde 8 metre, TRUCK araçlarında 12 metre bulunur.

Sürgülü ve açılır/küçültülebilir merdivendir. Aracın kurtarma dolabında katlı halde bulunur.



Hidrolik Çekme Vinci ve Mucurgat Makarası

FR aracı SUV, sedan çekecek güçtedir. SQUAD ve BP aracı ise tüm araçları çekebilecek düzeydedir.

Aracın arka ve ön kısımlarında araç çekim işlemleri için makaralı hidrolik çekme vinci bulunur. Müdahale yapılacak aracın uygun noktasına bağlanarak çekme işlemi gerçekleştirilir.



Ek İlave Hortumlar

TRUCK araçlarında bulunur.

İlgili araçların destek dolaplarında bulunur. Yangına müdahale eden ekibin hortum arızası ya da eksikliği yaşamaması durumunda kullanılır.



Aydınlatıcılar

TRUCK araçlarında bulunur.

Vaka bölgelerinde yetersiz ışık kaynağı olması durumunda katlanır ışık kulesiyle aydınlatma desteği verilir.



Benzinli Jeneratör

TRUCK araçlarında bulunur.

Elektrik yetersizliği durumlarında ya da geçici elektrik kesintisi yapılması gereken durumlarda jeneratör kullanılır.



Kriko Setleri ve Hava Yastıkları

TRUCK ve FR araçlarında bulunur.

Kapalı camı açma, araç kaldırma işlemleri gibi durumlarda kullanılır. Hava yastığı kapının düz arasından koyularak hava pompası yardımıyla şişirilir. Krikolar ise klasik araç kaldırma krikolarından farksızdır.



Atlama Yatağı ve Motoru

TRUCK araçlarında bulunur.

Genellikle intihar vakalarında kullanılır. Şişirme motoruyla şişirilir. Bir canlı zarar verebilecek düzeyde yükseklikten düşme riski yaşıyorsa da önlem olarak kurulur.



Benzinli Demir ve Beton Kesme Motoru

TRUCK ve FR araçlarında bulunur.

Cihaz, ipi çekiltilerek çalıştırılır ve yine ipi çekiltilerek pasif hale getirilir. Demir ya da betonları kesmek için kullanılır.



Benzinli Ahşap ve Odun Kesici

TRUCK ve FR araçlarında bulunur.

Cihaz, ipi çekiltilerek çalıştırılır ve yine ipi çekiltilerek pasif hale getirilir. Ağaç, odun ya da ahşap bir malzemeyi kesmek için kullanılır.



Hidrolik Ayırıcı ve Kesici

TRUCK ve FR araçlarında bulunur.

Güç ünitesine bağlanarak çalıştırılır. Büyük bir makas şeklindedir. Metal, demir gibi aletleri ayırmak ya da kesmek için kullanılır. Trafik kazası vakalarında sıkışma durumlarında sıkışan metalleri açmak ve germek için sıklıkla tercih edilir.



Balyoz, Çekiç, Balta, Levye, Kürek, Levye, Manivela, Holigan Aleti

TRUCK ve FR araçlarında bulunur.

Balyoz, betonların ve duvarların parçalanması içindir. **Balta**, küçük ahşap bölgelerin kırılımında kullanılır. **Kürek**, toprakları kazmak için kullanılır. **Manivela ve levye ve holigan aleti** araç kapısı gibi sıkışan bölgelerde zorla açma yapmak için kullanılır.



Arama Cihazları

SQUAD ve TRUCK araçlarında bulunur.

Sesli Arama Cihazı, görünmeyen bölgelere yerleştirilerek akustik dinleme yapar. Ses dalgasının algılanması durumunda cihaz sinyal verir ve bu sinyale göre arama faaliyeti devam eder. Bu cihaz kullanılmadan önce çevrede kesinlikle ses olmamalıdır. Bunun için anons geçilir.

Görüntülü Arama Cihazı, ses alınan ancak yeri tam olarak tespit edilemeyen afetzedelere zarar vermemek için kullanılır. Açılan 45mm çapındaki delikten cihaz ileriye doğru sokulur ve

afetzedenin tam konumu tespit edilmeye çalışılır. Tespit ardından kazma işlemi devam eder. Ayrıca termal ve gece görüşü gibi modlarıyla genel aramalarda da kullanılır.



Ölçüm Cihazları

TRUCK araçlarında bulunur.

Oksijen Ölçüm Cihazı, bölgenin oksijen seviyesini ölçmek için kullanılır. Cihaz **%21** altı değeri gösteriyorsa bu tehlikelidir ve oksijen tüpü ve maskeleri kullanılmalıdır. Yangın durumlarında itfaiye personeli yakın temasa geçmeden önce kullanılır.

Patlayıcı Gaz Dedektörleri, LPG, doğal gaz, hava gazı, asetilen gibi patlayıcı maddelerin yangını durumunda bölgede müdahale sırasında ölçüm yapılır. Personel yakın temasa geçmeden önce cihazla mutlaka ölçüm yapar. Dedektör uyarı veriyorsa uzaktan temasa devam edilmeli, içeri girilmemelidir.

Radyakmetre, bölgedeki radyasyon miktarını ölçmek için kullanılır. Cihaz uyarı verdiği vakit bölge terk edilmeli ve uyarı bölgesindeki herkes koruyucu ekipmanlar kuşanmalıdır.



6) AMBULANS EKİPMANLARI

X-Collar

Omurilik veya boyun civarı yaralanmalar mevcutsa oluşacak zararı engellemek için kullanılmalıdır. Araç kazalarında yapılması gereken ilk iş X-Collar uygulamaktır. X-Collar uygulandıktan sonra yaralının tedavisine başlanılır.

Kullanım;

- 1) X-Collar'ı tamamen açıp uzunlamasına genişletin ve yaralının boynuna sarın.
- 2) X-Collar'ı sardıktan sonra, plastik kilitleri birbirine geçirerek sabitleyin ve plastik kilidin ucunda bulunan 1 numaralı cırt cırtı çene altında bulunan 1 numaralı yere yapıştırınız.
- 3) X-Collar'ın göğüs destek kısmı için altta bulunan yerini tutarak beyaz noktalı köşeler köprücük kemiği hizasına denk gelecek şekilde aşağıya kadar indirin.
- 4) 2 numaralı cırtcırtları sırasıyla açın ve kişinin boynunu biraz sıkacak şekilde çekip yerlerine geri yapıştırın.
- 5) 3 numaralı cırtcırtları sırasıyla açın ve kişinin boynunu biraz sıkacak şekilde çekip yerlerine geri yapıştırın.



Resim 6.1(X-Collar)

KED Yeleđi

KED Yeleđi trafik kazalarında, dűřmelerde ve sıkıřma durumlarında ve Omurga veya boyun gibi önemli noktalarda yaralanmaları olan hastayı olduđu yerde stabilize etmek iin kullanılır. KED yeleđinden nce X-Collar takılması gerekmektedir.

Kullanım;

- 1) KED yeleđini aarak yaralının arkasından sırt blgesine yerleřtirin ve kiřinin kol altına dűzgűnce oturacak řekilde sarın.
- 2) KED yeleđinin nűnde bulunan  renkli kemer yardımıyla yeleđi sabitlemeye bařlayın.
- 3) İlk olarak orta sarı kemeri sıkarak kilidine takın. (Ortada bulunan kemer)
- 4) İkinci olarak kırmızı kemeri sıkarak kilidine takın. (En altta bulunan kemer)
- 5) ncű olarak yeřil kemeri kemeri sıkmadan kilidine takın. (En stte bulunan kemer.
- 6) KED yeleđinin arkasında bulunan siyah kemerleri sırasıyla nce kiřinin bacağıının dıřından geirin, sonra bacak arasından geirip geri ekerek kilidine takın.



Resim 6.2(KED Yeleđi)

Oropharyngeal Airway (OPA)

OPA kişinin boğazına baş aşağı yerleştirilen bir aygıttır. Böylelikle hastanın dili korumada olur ve boğulma riskini ortadan kaldırır.

Kullanım;

- 1) OPA'yı medikal çantanızdan çıkartın ve kişi için doğru boyutta olup olmadığına bakın. (OPA sanki kişinin ağzından sokulmuş gibi kişinin yanağına doğru yaslanır ve boyutun uygun olup olunmadığına bakılır)
- 2) Kişinin ağzını açarak OPA'yı baş aşağı olmak üzere kıvrık kısmın içi size bakacak şekilde ağızdan içeriye doğru ittirin.
- 3) OPA biraz ilerledikten damağa temas edecektir. Damak ile temas ettikten sonra yavaşça 180 derece olacak şekilde OPA'yı çevirin.



Resim 6.3(OPA)

Vario 18 (Taşınabilir vakumlu solunum yolları temizleme cihazı)

Vario 18 ile eğer ki hastanın solunum yollarını tıkayan bir sıvı bulunuyorsa (Kusmuk, kan vs.) vakumlayarak temizlenir. Bu işlem uygulanırken dikkatli olunması gerekir.

Kullanım;

- 1) Ambulanstan Vario 18 cihazı alınır ve yaralının yanına getirilir.
- 2) Yankauer kateterini cihazın üst kısmından bağlayın ve kateterin diğer ucunu yaralının boğazına kadar indirin.
- 3) Vakum seviyesini ayarlayın ve çalıştırma tuşuna basın.
- 4) Vakumlama işlemi bittikten sonra vakum seviyesini sıfıra indirip makineyi kapatın.



Resim 6.4(Vario 18)

Magill Pensi

Yaralının solunum yolunu tıkayan katı cisimleri çıkarmak veya entübasyon uygulamalarında zorlukla karşılaşıldığı durumlarda tüpün solunum borusuna yerleştirilmesinde kullanılır.

Kullanım

- 1) Sağlık çantasından Magill Pensi alın.
- 2) Uç kısımlarını katı cisme uzanana kadar ilerletin, nesneye ulaştığınızda pensin uç kısımlarıyla tutun ve çekerek çıkartın.
- 3)Entübasyon tüpü için kullanıyorsanız uç kısımlarla tüpü ağız içinde tutarak solunum borusuna ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.



Resim 6.5(Magill Pensi)

Laringoskop

Laringoskop gırtlak kısmında hava yolu açılmasını sağlayan ve yan tarafında bulunan ışık yardımı ile o bölgenin görünmesini mümkün bir alettir. Bu alet genellikle bilinç kaybı olan yaralılarda kullanılır. Kullanım amacı ise hastanın hava almasını sağlamak ve gırtlak, yemek borusu ve solunum yolunda bir sorun olup olmadığının incelenmesini sağlar. Laringoskop aleti genellikle entübasyon işlemi yapılırken ve solunum yolunu tıkayan bir cisim olup olmadığını görebilmek için kullanılır.

Kullanım;

- 1) Aletin kanca kısmını tutup çekerek açınız. Kanca kısmın açılmasıyla üzerined bulunan ışık yanmaya başlayacaktır.
- 2) Aletin kanca kısmından kişinin boğazına kadar ittiniz.
- 3) Solunum yolunu tıkayan bir cisim olup olmadığına bakın.
- 4) Solunum yolunu tıkayan bir cisim yoksa aletten yardım alarak entübasyon borusunu boğazdan içeri ittiniz. Solunum yolunu tıkayan bir cisim varsa aletin yardımcı ile birlikte magill pensi kullanarak cisme ulaşın.
- 5) Aleti yavaşça geri çekerek çıkartın ve kapatın.
- 6) Magill pensi ile cismi çıkartın.



Resim 6.5(Laringoskop)

Vakum Atel

Vakum atel kol ve bacak uzuvlarında oluřan kırılmalarda, yaralı uvzu sabitleyerek hareketsiz kalması saęlar. Kullanmadan önce bölgede kanama bulunuyorsa durdurulmalı ve gerekli müdahalede bulunulmalıdır.

Kullanım;

- 1) Vakum atel setinin taşıma çantasını aracınızdan alın.
- 2) Taşıma çantasından uygun uzvun boyuna göre olan ateli alın ve kırık uvzu hafifçe kaldırarak sarın ve klipslerini kapatın.
- 3) Vakum atelin üzerinde bulunan pompa kapaęını çevirerek açın ve çanta içerisinde bulunan pompayı kapaęa yerleřtirin.
- 4) Atelin uvza tam uyması ve sarması için pompa yoluyla bastır çek yaparak, uvza uyana ve tamamen hava ile dolup sertleřene kadar ateli řiřirin.
- 5) Pompayı yuvasından çıkartın ve pompa kapaęını ters yöne çevirerek kapatın.



Resim 6.6(Vakum Atel)

Üçgen Bandaj

Üçgen bandaj kol kırığından řüphe ediliyorsa kullanılır. Uygulamadan önce kesinlikle bir kanama bulunuyorsa durdurulması gerekmektedir.

Kullanım;

- 1) Yaralının kırık olduęu düşünölen kolunu sarsmayacak řekilde tutun.
- 2) Bandajı açarak yavaşça kolun alt kısmından geçirin ve öne doęru götürerek boyun bölgesinde birleřtirin.
- 3) Bandajın boyun arkasında kalan iki ucunu birbirine baęlayarak sabitleyin..



Resim 6.7(Üçgen Bandaj)

Traksiyon Atel

Traksiyon Atel diz kapağı ve kalça kemiğinde kırık bulunması sebebiyle kullanılan ateldir. Yalnızca bu bölge kırıkları için kullanılır. Bu bölgeler haricinde olan kırıklarda vakum atel ya kullanılması gerekmektedir.

Kullanım;

- 1) Kırık bulunan bacağı sarsmadan ve zorlamadan yerden birkaç santimetre yüksekliğe kaldırın.
- 2) Traksiyon ateli bacağın altına doğru sürün ve bacağı üzerine yerleştirin.
- 3) Ön kısımda kalan tüm klipsler geçirilerek ateli bacağı sabitleyin.



Resim 6.8(Traksiyon Atel)

Defibrilatör (AED)

Defibrilatör cihazı yaralının kalbinin durduğu zamanlarda anlık şok yardımı ile kalp atışlarını geri getirmeye yarar.

Kullanım;

- 1) Ambulansınızdan AED setini alın ve yaralının yanına yerleştirin. Daha sonrasında üst kısımda bulunan on/off tuşuna basarak AED’i çalıştırın.
- 2) AED’den iki kere bip sesi gelmesini bekleyin. Geldikten sonra pedleri yaralının sağ göğsünün üzerine ve belinin solundan, sol göğsün bitiş kısmına yapıştırın.
- 3) AED sesli komutu analiz için hazır olduğunu söyleyecek ve kişinin değerlerini kontrol edecektir. “Analiz yapılıyor” sesini duyduktan sonra nu süreçte cihazın analizini tamamlamasını bekleyin.
- 4) AED cihazı analizi tamamladıktan sonra şok vermek için ayarlamaları yapacaktır. Bu ayarlamalar bittikten sonra şok verimine hazır olduğuna dair sesli bir komut ile sizi bilgilendirecektir. “Şok verin.” komutunu aldıktan sonra cihazın üzerinde bulunan şok verme butonuna tıklayın.
- 5) AED cihazı şok sonrasında size “Şok verildi.” şeklinde bir dönüş sağlayacaktır. Bundan sonrasında CPR’a devam edebilirsiniz.



Resim 6.9(Defibrilatör)

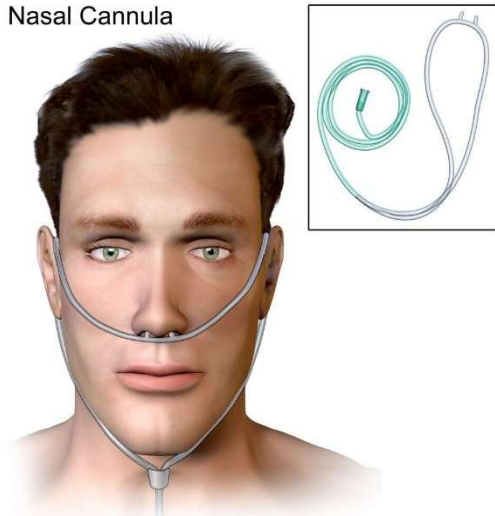
Nasal Cannula

Nasal Cannula iki adet küçük ve bir adet uzun plastik tüple vücuda burun yardımı ile oksijen sağlar. Dakikada 1-6 oranında oksijen sağlamaktadır. Düşük yoğunlukta oksijen alması gereken yaralılarda, oksijen verildiğinde rahatlayacağını düşünen yaralılarda, maske kullanamayan yaralılarda kullanılır.

Kullanım;

- 1) Sağlık çantanızdan Nasal Cannula ve taşınabilir O2 tüpünü alın.
- 2) Tüpün üzerinden oksijen miktarını ayarlayın.
- 3) Elinizi burun kısmına girecek olan iki tüpün üzerine getirerek havanın geldiğinden emin olun.
- 4) İki ucuda hastanın burun deliklerine yavaşça yerleştirin ve boşta kalan uzun kısmı kulaklarının üzerinden geçirip ön tarafa doğru uzatın.

Nasal Cannula



Resim 6.1.0(Nasal Cannula)

Non-rebreather mask (NRB)

NRB maskesi dışarıdan içeri hava almaz ama içeriden dışarıya hava atabilen bir hazneye sahiptir. Dakikada 10-15 oranında oksijen sağlamaktadır. NRB maskesi baygın yaralılarda veya fazlaca oksijensiz kalındığında kullanılır.

Kullanım;

- 1) Sağlık çantanızdan NRB maskesini ve taşınabilir O2 tüpünü alın.
- 2) Maskeyi oksijen tüpüne bağlayın, tüpün üzerinden gerekli oksijen miktarını ayarlayın ve açın.
- 3) Maskeyi hastanın ağzını ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirin.
- 4) Maskenin elastikliğini kafa arkasına geçirerek yaralıya sabitleyin.



Resim 6.1.1(Non-rebreather mask - NRB)

Bag Valve Mask (BVM) (Balon Valf Maske)

BVM manuel olarak kişinin solunum işlevini yerine getirmesini sağlamakta kullanılır. Direkt olarak akciğerlere hava gönderir. Yaralının nefes almadığı durumlarda kullanılır.

Kullanım;

- 1) Sağlık çantanızdan masketi çıkartın ve baş geri çene yukarı hareketini uygulayarak yaralının ağzını açın.
- 2) Maskeyi yaralının ağız ve burun kısmını içine alacak şekilde yerleştirin. Maskenin ete tamamen değdiğine emin olun.
- 3) Torba kısmını belirli aralıklarla sıkıp bırakın.
- 4) Dakikada 10-12 defa sıkıp bırakılma işlemi yapılır. CPR'da ise her 30 baskıda 2 defa yapılır.



Resim 6.1.2(Bag Valve Mask - BVM)

Nabız ölçer

Yaralının nabız değerini ölçmek için kullanılır. Kullanımı kolay ve hızlı bir alettir.

Kullanım;

- 1) Sağlık çantanızdan Nabız ölçeri çıkartın.
- 2) Mandal kısmına basarak ucunun açılmasını sağlayın ve yaralı kişinin işaret parmağına yerleştirin.
- 3) Üzerinde bulunan tuşa basarak aleti çalıştırın.
- 4) Ekrana bakarak kişinin değerlerini öğrenin.



Resim 6.1.3(Nabız Ölçer – Pulse Oksimetre)

Ana Sedye

Ana sedye diğer sedyelerden kendisine yaralı transferi sonrasında yaralının hastaneye ulaşım sürecinde veya bilinçli hafif yaralanmalarda hastayı direkt ambulansa transfer etmek için kullanılır.

Kullanım;

- 1) Ambulansdan indirmek için ambulansın sedye kısmında bulunan rampayı açın ve sedyeyi dışarı çıkartın.
- 2) Sedyenin üzerinde bulunan mandal ile yükseltip alçatabilirsiniz.
- 3) Sedyenin yanında açılıp kapanabilir bir serum askısı ve koruyucu bariyerleri vardır.



Resim 6.1.4(Ana Sedye)

Kombinasyon Sedye

Hem tekerlekli sandalye hem de sedye olarak kullanılabilir. Yaralının konforunu ve güvenliğini sağlamak için çeşitli pozisyonlara ayarlanabilir. Yarı oturur veya tamamen yatay pozisyonda kullanabilen bu sedyeler özellikle omurga yaralanmaları gibi durumlarda avantaj sağlar.

Kullanım;

- 1) Alt teker bağlantı borusuna basılır.
- 2) Sedye sokulmak istediği pozisyona göre eklem yerilerinden çekilir ya da bükülerek konumlandırılır.
- 3) Yaralı yerleştirildikten sonra göğüs kemerleri kol altından geçirilerek sabitlenir, sonrasında bacak kemerleri takılır.
- 4) Yaralı üzerindeyken durumunun kötüleşmesi durumunda sedyeyinin alt kısmında bulunan kilit açılır.
- 5) Yaralının ayaklarının olduğu kısım tutularak ileri doğru çekilirken baş kısmı yavaşça geriye yatırılarak düz bir sedye haline getirilebilir. Müdahale sonrasında ana sedyeye yerleştirilir.



Resim 6.1.5(Kombinasyon Sedye)

Faraş Sedye

Boyun, omurga ve pelvis tranvalarında kullanılan bir sedyedir. Taşıma sedyesi değildir, yaralıyı bulunduğu yerden alıp, başka bir sedyeye transfer etmek için kullanılır. Taşıma kapasitesi 200 kilogramdır. Fazlası ağırlıkta yaralının ve sedyenin zarar görebilmesi mümkündür.

Kullanım;

- 1)** Sedye hasta yanına uzandırılır, kilit mekanizmaları açılarak yaralının boyuna göre sedyenin boyu ayarlanır. Kilit mekanizması kapatılır.
- 2)** Her iki kişi karşılıklı olarak sedye basma ayırma düğmesine basarak sedyeyi iki ayrı parçaya ayırır.
- 3)** Parçalardan bir tanesi hastanın yanından altına doğru itirilerek yerleştirilir.
- 4)** Diğer parçanın yerleştirilmesi için hasta öbür taraftan tutularak hafifçe kaldırılır. Parça altına sürülür ve hasta geri yatırılır.
- 5)** Sedyenin parçaları tekrardan birbirine takılıp birleştirilir ve tam birleştiklerinden emin olunur. Hasta kaldırılarak diğer sedyeye transfer edilir.
- 6)** Yaralının durumu ağırsa, hareketinin iyice sabitlenmesi için sedyenin kemerleri kullanılabilir.



Resim 6.1.6(Faraş Sedye)

Vakum Sedye

Travmalı yaralanmalarda, immobilizasyon ve güvenli yaralı transferinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yumuşak haldeki sedye vakumlandığında sertleşerek, yaralının vücudunu sarar. Sürtünme ve yırtılmaya dayanıklı, hafif malzemeden üretilmiştir. Vakum sedye, hızlı emiş sağlayan ve elle çalışan bir vakum pompası ile şişirilecek şekilde bir setten oluşmaktadır. Hasta konulduğu zaman, taşınmasını kolaylaştıracak kayışlar ve 4 adet yan tutamağı mevcuttur.

Kullanım;

- 1) Yaralı sedye üzerine yatırılır ve kemerleri bağlanır.
- 2) Sedye valfi açılarak pompalanır ve şişirilir.
- 3) Dört personel yan tutacaklarından tutarak sedyeyi taşır.
- 4) Vaka sonunda sedye valfi açılarak tekrardan havası alınır.



Resim 6.1.7(Vakum Sedye)

Omurga Tahtası

Travma varlığı ya da şüphesi varsa hasta öncelikle omurga tahtası üzerine alınır. Her trafik kazası vakalarında yaralı vaka önlem için öncelikle omurga tahtasına yatırılır.

Kullanım;

- 1) Yerdeki yaralının yanında omurga tahtası açılır.
- 2) Yaralıya önce boyunluk takılır.
- 3) Komut ile beraber eş zamanlı olarak yaralı omurga tahtasına alınır.
- 4) Boyun bantları yerleştirilir, kemer bağlanır.
- 5) Omurga tahtası üzerindeki yaralı sedyeye alınır.



Resim 6.1.8(Omurga Tahtası – Sırt Tahtası)

7) EKİPLERİN VAKAYA GÖRE DAĞILIMI

- **RESCUE AMBULANCE (RA)**

Rutin medikal devriyeler,

- Her türlü medikal vakayı yanıtlama görevi,

- **FAST-RESPONSE**

- Rutin her amaçlı (itfaiye, medikal, kurtarma) devriyeler,
- Medikal, itfaiye ve kurtarma vakalarına ek destek,
- Vaka sonrası olay yeri temizliği (ex, trafik kazası vs.)

- **BATTALION & EMS**

- Amir saha devriyeleri,
- Vaka yönetimi aracı,
- Medikal, itfaiye ve kurtarma vakalarına ek destek ve inceleme

- **LIFE-GUARD**

- Plaj ve sahil etkinliklerinde önlem için bekleme görevi,
- Plaj ve sahil devriyeleri,
- Su sporları destek ünitesi,

- **BRUSH-PATROL**

- Doğa etkinliklerinde bölgede önlem için bekleme görevi,
- Orman ve doğa devriyeleri,
- Off-Road yardımları (saplanma, arıza vs.),
- Çalı ve ormanlık alan yangınlarına destek,

- **SQUAD**

- Trafik kazalarında sıkışmaya müdahale etme, yangın riskini ortadan kaldırmak,
- Yangın vakalarına ek destek,
- Zehirli gaz ve radyasyon bölgelerine destek, afet vakalarına destek,

- **LADDER**

- Yerden yüksek yangın vakalarına destek,
- Yerden yüksek kurtarma vakalarına destek,

- **ENGINE**

- Tüm yangın vakalarına öncü,
- Su dolum görevleri,
- Hidrant bakımları,
- Su baskınları,

- **WATER-TANK**

- Büyük yangın vakalarında ek su tankı desteği,
- Su dolum görevleri,
- Büyük çaplı su baskınları,

- **BOAT**

- Deniz ve göletlerde gerçekleşen her türlü medikal / kurtarma / yangın vakalarına destek,
- Sahil güvenlik devriyeleri,

- **RESCUE-HELI**

- Büyük yangın ya da araç girişi mümkün olmayan yangın vakalarına havadan destek,
- Arama ve kurtarma faaliyetleri,
- Orman ve çalılık alan rutin devriyeleri,

- **EMERGENCY-HELI**

- Uzak lokasyon ya da araç girişi mümkün olmayan medikal vakalarda hasta/yaralıya ulaşma, yüksek riskli hasta taşıma,

- **ARSON**

- Yangın dedektiflerinin yangın bölgelerine yönelmesi için kullanılan araç.

8-) KIDEM VE DEVRIYE İZİNLERİ

[!] Sahada aynı anda iki tekli devriye bulunması önerilmez. Çiftli devriye önerilir. Sahada tekli bir devriye varken istasyondaki personelin yeni bir devriye oluşturmak yerine mevcut devriyeye katılması gerekir.

[!] Birim devriyeleri sahada en az 3 ekip olmadan oluşturulamaz.

- **RESCUE AMBULANCE (RA)**

- İtfaiye Eri I ve üzeri tekli devriyeye çıkabilir.
- Sahada en az bir adet bulunmalıdır.

- **FAST-RESPONSE**

- Sahada en az 1 RA ekibi olmadan bu devriye oluşturulamaz.
- İtfaiye Eri I ve üzeri şartları karşılıyorsa tekli devriyeye çıkabilir.

- **BATTALION & EMS**

- Teknisyen ve üzeri çıkabilir.
- Rutin telsiz anonsları vermesi beklenmez.

- **LIFE-GUARD**

- LIFE-GUARD birimi personelleri oluşturabilir.

- **BRUSH-PATROL**

- Amirlerlerin özel izniyle oluşturulabilir.
- Çağrı gelmesi üzerine de müsait personeller tarafından oluşturulup çağrı yanıtlanabilir.

- **SQUAD**

- HAZ-MAT birim personelleri tarafından oluşturulur.

- **LADDER**

- İhtiyaç halinde oluşturulur.

- **ENGINE**

- İhtiyaç halinde oluşturulur.

- **WATER-TANK**

- İhtiyaç halinde oluşturulur.

- **BOAT**

- LIFE-GUARD birim personelleri oluşturabilir.

- **RESCUE-HELI**

- Hava birimi personeli oluşturur.

- **EMERGENCY-HELI**

- Hava birimi personeli oluşturur.

- **ARSON**

- ARSON birimi personeli oluşturur.

İlaçlar ve Kullanım Alanları

Ön Bilgi

Acil durumlarda doğru ilaç kullanımı, hayat kurtarmada kritik bir rol oynar. Bu ilaçlar, hastanın durumunu stabilize etmek, ağrıyı yönetmek ve yaşam tehditlerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Doğru tanı ve hızlı müdahale, sağlık profesyonellerinin en önemli görevlerinden biridir.

Ambulansta Bulunan İlaç ve Serumlar:

Adrenalin Amp. 1 mg. (10 Adet)
Aminocardol Amp. (4 Adet)
Atropin Amp. 0.5 mg. (10 Adet)
Antihistaminik Amp. (4 Adet)
Beta Bloker Ampul (2 Adet)
Spazmolitik Amp. (4 Adet)
Calcium Amp. (3 Adet)
Citanest Flk. (Prilocine) (1 Adet)
Kortikosteroid Amp. (10 Adet)
Diazepam Amp. (5 Adet)
Diltiazem 25 mg. Ampul (2 Adet)
Dopamin 40 Ampul (2 Adet)
Dormicum 5 mg Ampul (1 Adet)
Antiemetik Amp. (2 Adet)
Antiepileptik Ampul (2 Adet)
Etil Chloride Sprey (1 Adet)
Isoptin Ampul (2 Adet)
Jetocaine Amp. (2 Adet)
Lasix Ampul (Furosemide) (5 Adet)
Amiodarone Ampul (2 Adet)
Analjezik Amp. (10 Adet)
Nahco3 Amp. (10 Adet)
Naloksan Ampul (1 Adet)
Nitrodrem TTS 5 mg ve 10 mg (2 Adet)
H2 Bloker Amp. (4 Adet)
Serum Fizyolojik Amp. (10 Adet)
Inhaler veya Nebul (Salbutamol) (6 Adet)
Anestezik Pomad (2 Adet)
Antimikrobial Pomad (2 Adet)
Silverdin Pomad (2 Adet)
Asetilsalisilik Asit tb. (10 Adet)
Aktif Kömür Tüp (2 Adet)
Isordil 5 mg tb. (1 Adet)
Kaptopril tb. 25 mg (1 Adet)
Isolyte 500 cc. (5 Adet)
Isolyte p 500 cc. (5 Adet)
Isolyte s 500 cc. (5 Adet)
Izotonik 500 cc. (5 Adet)
Mannitol 500 cc. (2 Adet)
Ringer laktat 500cc (5 Adet)
Magnezyum Sülfat (5 Adet)
Flumazenil (2 Adet)
Paracetamol Tablet (10 Adet)

Adrenalin / Epinefrin

Kullanımı: Kalp durması, anafilaksi (alerjik reaksiyonlar), şok ve bronkospazmda kullanılır. Kan basıncını artırır ve kalp ritmini düzenler.

Dozajları: 1 mg, 0.25 mg

Enjekte: IV, IM, endotrakeal tüp.

Aminocardol

Kullanımı: Yüksek tansiyon, aritmi ve kalp krizi sonrasında kalp üzerindeki yükü azaltmak için kullanılır.

Dozajları: 5 mg (her 5 dakikada bir, toplam 15 mg'a kadar)

Enjekte: IV yavaş enjeksiyon.

Atropin

Kullanımı: Düşük nabız, kalp kasılma yetersizliği, kalp bloğu durumlarında kullanılır. Tansiyonu düşürür.

Dozajları: 1 mg, 0.5 mg, 0.25 mg

Enjekte: IV, endotrakeal tüp.

Beta Bloker Ampul

Kullanımı: Yüksek tansiyon krizleri ve kalp ritim bozuklukları (aritmi) için kullanılır. Kalp hızını düşürür.

Dozajları: 1-2 mg (her 5 dakikada bir, toplam 10 mg'a kadar)

Enjekte: IV yavaş enjeksiyon.

Dopamin

Kullanımı: Şok, kalp yetmezliği, kalp krizi durumlarında kullanılır. Kan basıncını arttırmak ve kalp fonksiyonlarını dengelemek için yardımcıdır.

Dozajları: 1 mg.

Enjekte: 100 cc izotonik serum içine 1 ampul dopamin.

Diazepam Ampul

Kullanımı: Anksiyete, nöbetler ve kas spazmlarını tedavi etmek için kullanılır.

Dozajları: 5-10 mg

Enjekte: IV yavaş enjeksiyon, IM.

Antiepileptik Ampul

Kullanımı: Epileptik nöbetleri kontrol etmek için kullanılır.

Dozajları: 5-10 mg

Enjekte: IV yavaş enjeksiyon.

Analjezik Ampul

Kullanımı: Ağrı kesici olarak kullanılır. Çeşitli ağrı türlerinin hafifletilmesinde etkilidir.

Dozajları: 50-100 mg

Enjekte: IV, IM.

Silverdin Pomad

Kullanımı: Yanık yaralarında enfeksiyonu önlemek ve yara iyileşmesini hızlandırmak için kullanılır.

Dozajları: Gerekli kadar.

Enjekte: Cilde uygulanır (topikal).

Aktif Kömür Tüp

Kullanımı: Zehirlenme durumlarında toksinleri bağlayarak emilimini engeller.

Dozajları: 50-100 gram (oral)

Enjekte: Ağız yoluyla.

Antimikrobiyal Pomad

Kullanımı: Enfekte olmuş cilt yaraları ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Antibakteriyel etki sağlar.

Dozajları: Gerekli kadar.

Enjekte: Cilde uygulanır (topikal).

İzolyte 500 cc

Kullanımı: Elektrolit dengesini sağlamak ve sıvı tedavisi amacıyla kullanılır. Dehidratasyon ve şok tedavisinde etkilidir.

Dozajları: 500 cc.

Enjekte: IV infüzyon.

Verapamil

Kullanımı: Kalp ritim bozuklukları (aritm) ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.

Dozajları: 5-10 mg

Enjekte: IV yavaş enjeksiyon.

Paracetamol Tablet

Kullanımı: Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda etkilidir.

Dozajları: 500-1000 mg (oral)

Enjekte: Ağız yoluyla.

Naloxan Ampul

Kullanımı: Opioid aşırı dozunu tersine çevirmek için kullanılır. Solunum depresyonunu düzeltir ve bilinç kaybını geri kazandırır.

Dozajları: 0.4-2 mg (IV, IM; gerekirse 2-3 dakikada bir tekrar edilebilir)

Enjekte: IV, IM.

Morfin Ampul

Kullanımı: Güçlü ağrı durumlarında, akciğer ödeminde, anesteziye giriş ve sürdürülemez durumlarında kullanılır.

Dozajı: 1 ampul = 1 cc = 10 mg

Enjekte: 1 ampul 9 cc serum fizyolojik ile sulandırılmalı, yavaş yapılmalıdır.

IV Yöntemi / Damar Yolu Açma

IV enjeksiyon yöntemi, damar yolu açmanın en yaygın ve etkili tekniklerinden biridir. Bu yöntem, acil durumlarda sıvı ve ilaçların doğrudan damara verilmesi gerektiğinde kritik öneme sahiptir. Doğru uygulandığında, hızlı ve güvenilir bir şekilde tedavi sağlamaya yardımcı olur.

IV yöntemi:

- İlk olarak, bilek veya biceps bölgesinde belirgin bir damar bulmalısınız. İki parmağınızı kullanarak damarı hissedin ve görsel olarak da değerlendirin. Damara ulaşmak için hastanın kolunu hafifçe aşağıda tutmasını isteyin.
- Bulduğunuz damarı son bir kez kontrol edin; damar sağlam ve şişkin olmalıdır. Ardından, bölgeyi alkollü bir pamukla dikkatlice temizleyin. Bu, enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.
- IV iğnesini yavaşça damara sokun ve hafif bir baskı uygulayın. Damarın içine girdiğinizde kan geri akışı gözlemlemelisiniz. Bu, iğnenizin doğru yerde olduğunu gösterir.
- Kateteri iğnenin etrafından içe doğru itin ve ardından iğneyi dikkatlice çıkarın. Kateterin damarda kalması gerektiğini unutmayın.
- İşleminizi tamamladıktan sonra, kateteri köşelerinden flaster ile sabitleyin. Böylece hareket esnasında kateterin yerinden çıkmasını önlemiş olursunuz.
- Son olarak, IV seti bağlayarak serum veya ilacı verirken dikkatli olun. Hava kabarcıklarını kontrol edin ve akışı izleyin.